

# 내시경이 정상인데 왜 계속 쓰릴까요?

기능성·과민성 소화불량의 이해와 관리 — 약을 끊으면 재발하는 쓰림, 그 이유와 단계적 해법을  
함께 봅니다

# 내시경이 깨끗한데 증상이 있는 이유

뇌-장 상호작용 장애(DGBI) — 눈에 보이는 상처가 아니라, 신경이 예민해진 상태입니다

## 신경 과민

內臟過敏

### 내장 과민성

정상이면 못 느낄 자극(산·  
팽창)을  
식도·위 신경이 통증으로  
느낍니다

## 위 적응

弛緩 장애

### 위 적응 장애

음식이 들어와도 위가 잘  
늘지 않아  
조금만 먹어도 더부룩·금세  
부릅니다

## 미세 염증

十二指腸

### 십이지장 미세 염증

내시경에 안 보이는 미세한  
염증·투과성  
변화가 신경을 더 예민하게  
만듭니다



**핵심** — 궤병이나 “마음의 문제”가 아니라, 신경·운동·미세염증이 얹힌 **실재하는 생리적 이상**입니다. 상처(궤양·식도염)가 없어도 신경이 예민하면 똑같이 아프고 쓰릴 수 있습니다. 그래서 산약만으로는 잘 안 듣고, 끊으면 재발합니다.

# 흔한 오해 3가지 — 바로잡기

이 오해들 때문에 치료가 잘못된 방향으로 흐르기 쉽습니다

## 오해 01

### “위산만 줄이면 낫는다”

산은 원인의 일부일 뿐입니다. 그래서 산약이  
'조금'만 들고, 끊으면 재발합니다.

→ 산을 넘어 신경 과민을 함께 다스려야 합니다.

## 오해 02

### “자다 깨는 건 저혈당 때문”

야간 저혈당 반동(소모기 현상) 같은 원인은  
실제로는 드뭅니다.

→ 야간 증상은 대개 역류·신경 과민이  
원인입니다.

## 오해 03

### “신경성 = 궤병”

'신경성'은 궤병이 아니라, 장 신경이 실제로  
예민해진 의학적 상태입니다.

→ 의지 문제가 아니라 치료가 되는 병입니다.

# 먼저 무엇을 확인하나 — 필요한 검사

‘다른 병이 숨어 있지 않은지’ 확인한 뒤, 안심하고 과민성 치료로 넘어갑니다

01 **식도 조직검사** — 내시경이 정상으로 보여도 호산구식도염을 놓치지 않으려고 조직을 떼어 확인합니다.

02 **헬리코박터 검사·제균** — 균이 있으면 없애는 것만으로 소화불량이 좋아지는 분이 있어 먼저 확인합니다.

03 **산도-임피던스 검사** — 필요시. 실제 역류량과 증상이 산 때문인지, 예민함 때문인지 구분합니다.

04 **식도내압 검사** — 필요시. 식도 운동·삼킴 장애 등 다른 원인을 함께 가려냅니다.

05 **위배출 검사** — 식후 더부룩함·구토가 두드러질 때, 위가 비워지는 속도를 확인합니다.

06 **왜 하나요** — 검사는 ‘병을 찾으려고’가 아니라, **위험한 병을 배제하고** 안심하기 위해서입니다.

# 세 가지 유형으로 나눠 봅니다

같은 '쓰림'이라도 유형에 따라 치료가 달라집니다 — 그래서 구분이 중요합니다

## TYPE · 01

### 진짜 산역류 (NERD)

위산이 실제로 많이 올라옵니다. 내시경은 정상이지만 산 노출이 증가한 상태로, **산약이 잘 듣는** 유형입니다.

## TYPE · 02

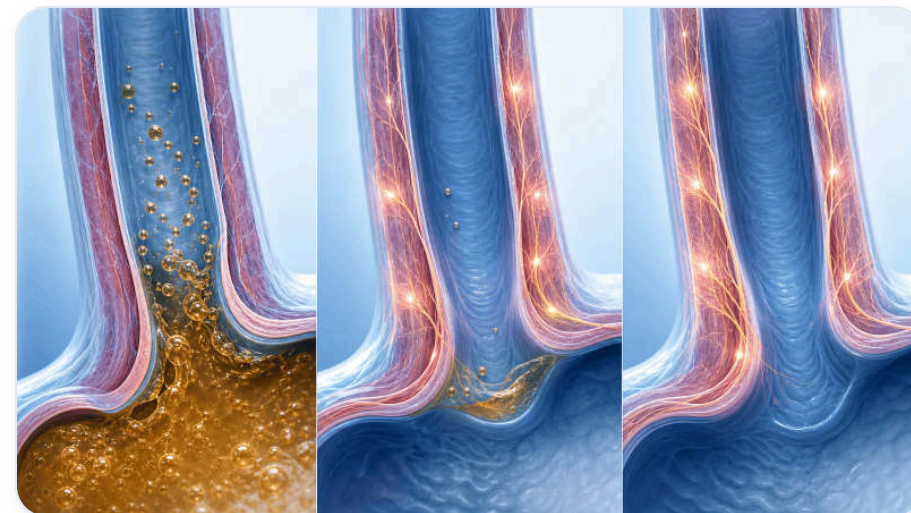
### 역류 과민성

산 노출은 정상인데, **정상 범위의 역류에도 예민하게** 반응해 쓰림을 느낍니다. 신경 조절이 핵심입니다.

## TYPE · 03

### 기능성 가슴쓰림

증상이 **산과 거의 무관**합니다. 식도 신경의 과민이 주원인이라, 산약보다 신경·행동 치료가 중심입니다.



# 치료의 큰 그림 — 발상의 전환

안 들으면 '더 센 산약'이 아니라, '다른 종류의 치료'로 방향을 바꿉니다

## 1단계 — 산약을 '제대로'

- **식전 30분 복용** — 약효를 최대한 끌어올리는 복용 타이밍
- **필요시 분복** — 아침·저녁으로 나눠 야간 증상까지 덮기
- **P-CAB 전환** — 기존 PPI로 부족하면 더 빠르고 강한 산 억제제로

※ 여기까지 충분히 했는데도 증상이 남으면 — 그건 '산이 부족해서'가 아니라 **신경이 예민해서**일 가능성이 큼니다.

## 2단계 — 방향 전환

- **더 센 산약 X** — 산을 더 줄여도 예민함은 그대로입니다
- **신경 다스리는 약 O** — 예민해진 장 신경의 '불륨'을 낮춥니다
- **생활·행동 교정 O** — 호흡·수면·식사 패턴으로 신경을 안정시킵니다

※ 핵심 메시지: **"약을 끊으면 재발" → "신경 과민을 다스리는 치료로 전환"**이 회복의 갈림길입니다.



# 신경을 다스리는 약(neuromodulator)

우울증약이 아니라, 과민해진 장 신경의 '불륨'을 낮추는 약입니다 — 저용량으로 시작합니다

## 통증·작열형이면

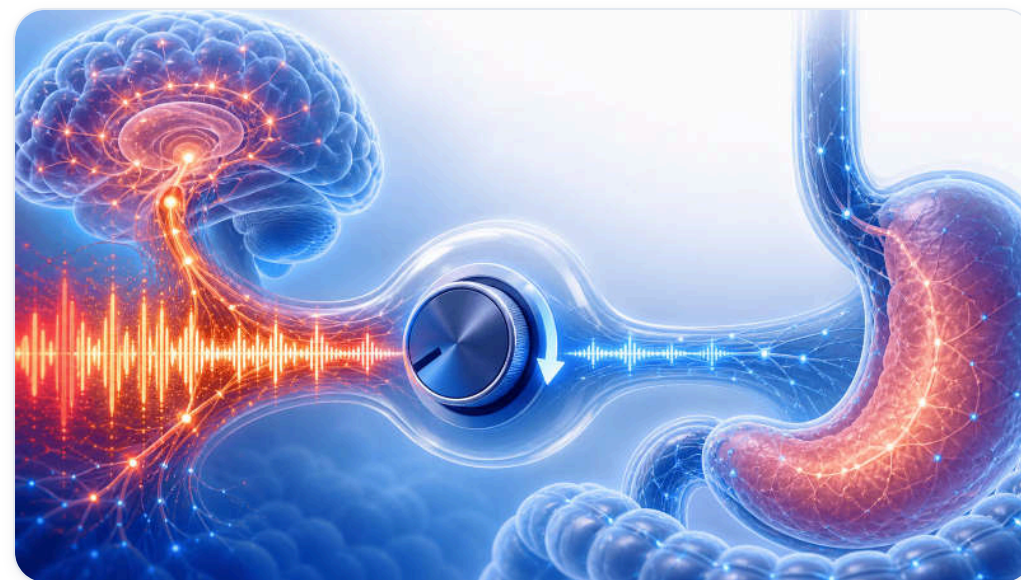
- **저용량 삼환계 (amitriptyline)** — 통증 신호 자체를 무디게 해 쓰림·작열감을 줄입니다
- 우울증 용량보다 **훨씬 낮은 용량**으로, 취침 전에 시작합니다

※ “신경을 끄는” 약이 아니라, **과민하게 커진 통증 신호의 불륨**을 낮추는 약입니다.

## 더부룩·조기만복·체중감소형이면

- **mirtazapine** — 입맛·메스꺼움·조기 포만에 도움(체중 감소 동반 시 이점)
- **buspirone** — 위 적응(이완)을 도와 식후 팽만을 완화
- **acotiamide** — 위 운동을 도와 식후 불편을 줄임

※ 증상 ‘유형’에 맞춰 약을 고릅니다.  
효과는 보통 **2~4주에 걸쳐** 서서히 나타납니다.





# 약제 주의점.부작용 (진료참고용)

저용량 시작.점진 증량 원칙 — 환자 동반질환에 따라 개별화합니다

| 약제                               | 주요 부작용.상호작용                                                  | 실무 포인트              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>amitriptyline</b><br>삼환계(TCA) | 구갈·변비·졸음·체중↑·기립저혈압·요폐·녹내장 악화, 고용량 QT 연장. 노인·심질환에서 항콜린·낙상 위험. | 저용량 취침 전 시작, 천천히 증량 |
| <b>mirtazapine</b>               | 진정·졸음·식욕↑·체중↑ (체중감소형엔 오히려 이점), 드물게 호중구감소.                    | 취침 전 복용, 혈구 이상 시 점검 |
| <b>bupirone</b>                  | 어지럼·두통·오심. CYP3A4 상호작용(자몽·케토코나졸), MAOI 병용 금기, 세로토닌증후군 주의.    | 비교적 순함, 식전 위 이완 목적  |
| <b>acotiamide</b>                | 내약성 양호. 경미한 설사·오심, 드물게 간효소 상승.                               | 식전 복용, 간수치 필요시 확인   |



# 함께 쓸 수 있는 보조 카드

증상과 상황에 맞춰 골라 더하는, 보조적인 선택지입니다

## ADD-ON · 01

### 위장운동 촉진제

itopride · mosapride · acotiamide — 위가 잘 비워지게 도와 식후 더부룩함·조기 포만을 줄입니다.

## ADD-ON · 02

### 알기네이트 (가비스콘)

식후 위 윗부분에 뜨는 산 주머니(acid pocket)를 막아, 식후 역류·쓰림을 빠르게 가라앉힙니다.

## ADD-ON · 03

### baclofen

짖은 트림·반추(되새김)가 동반될 때 더해 보는 약입니다. 하부식도 괄약근 이완을 줄입니다.

## ADD-ON · 04

### 헬리코박터 제균

감염이 확인되면 제균. 일부 환자에서 제균만으로 소화불량 증상이 호전됩니다.

# 생활습관 교정 — “꿈을 음식이 없다 ≠ 할 게 없다”

금지 음식 목록보다, 신경을 안정시키는 ‘습관’이 더 중요합니다 — 우선순위 순서대로

## 01 횡격막(복식) 호흡 — 식후 특히

이 유형에서 유일하게 RCT 근거가 있는 방법. 식후 천천히 배로 숨쉬기.

## 02 충분한 수면

잠이 부족하면 통증이 더 예민해집니다. 규칙적인 수면이 곧 치료입니다.

## 03 소량·천천히·저지방

조금씩 천천히, 기름진 음식은 줄이고, 저녁은 잠들기 3시간 전까지.

## 04 2주 식품일기로 내 트리거 찾기

남이 아닌 ‘내’ 유발 음식을 기록으로 찾기. 팽만 심하면 저FODMAP 4주 시도.

## 05 야간 증상이 있으면

침대 머리를 10~15cm 올리고, 왼쪽으로 누워 자면 야간 역류가 줄어듭니다.

※ 정상 체중이면 체중 감량은 해당되지 않습니다. 또한 생활습관 교정의 근거는 전반적으로 약한 편이라, ‘완치 수단’보다는 약물 치료를 돕는 **보조 축**으로 함께 합니다.

# 행동·심리 치료 — '신경 과민'을 직접 낮춥니다

약에 못지않게 효과가 오래갑니다 — 뇌-장 축을 직접 다스리는 방법

## 방법 · 01

### 횡격막 호흡 훈련

배로 천천히 쉬는 훈련을 반복하면  
자율신경이 안정되고, 식후 역류·트림이  
줄어듭니다.

## 방법 · 02

### 인지행동치료 · 장지향 최면

과민한 뇌-장 회로를 다시 길들이는 치료.  
약물에 필적하고 효과가 오래 지속됩니다.

## 방법 · 03

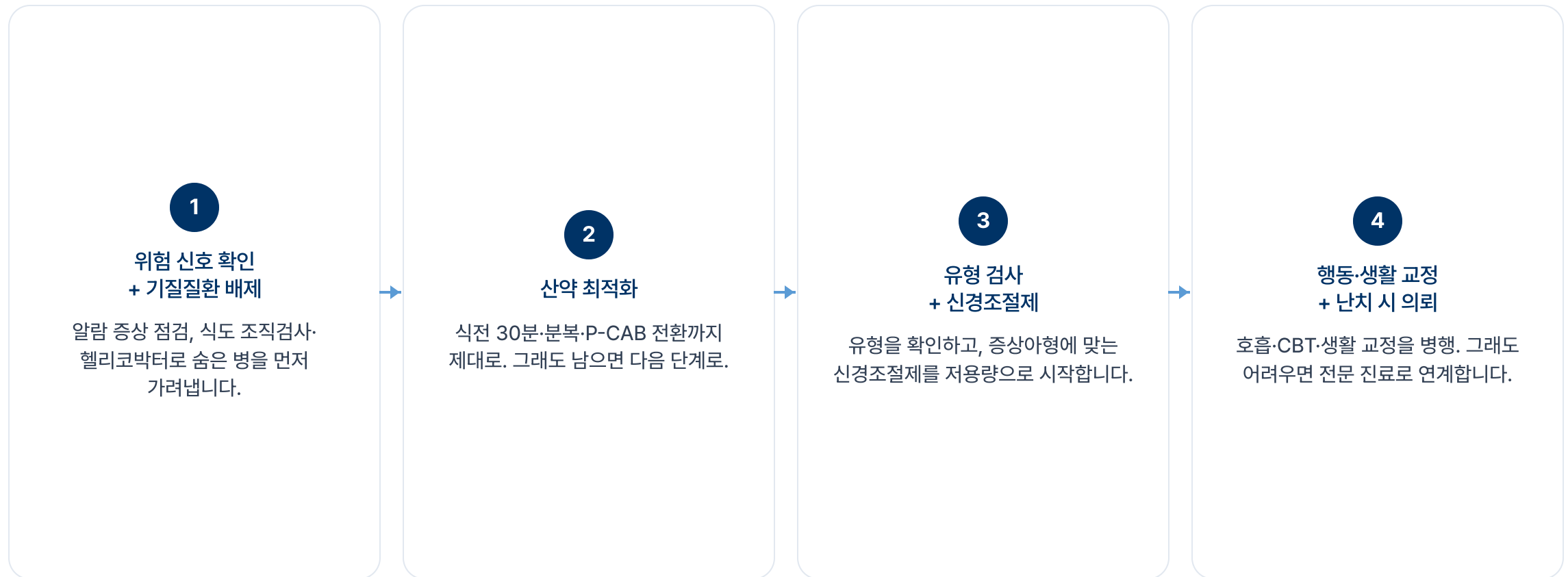
### 스트레스·자율신경 관리

규칙적 생활·이완·가벼운 운동으로  
스트레스를 낮추면, 장 신경의 예민함도  
함께 가라앉습니다.



# 단계별 관리 — 한눈에 보기

조급해하지 않고, 한 단계씩 차근차근 함께 올라갑니다



# 실재하는 과민성을 다스리는 병 함께, 단계적으로

피병이 아닙니다. 한 번에 끝내는 약은 없지만, 단계적으로 분명히 좋아질 수 있습니다

## 🚨 이런 신호는 바로 검사

체중 감소 · 삼키기가 어려움 · 출혈(흑색변·토혈) · 빈혈 · 멍지 않는 구토 — 한 가지라도 있으면 '과민성'으로 넘기지 말고  
즉시 검사합니다.



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요